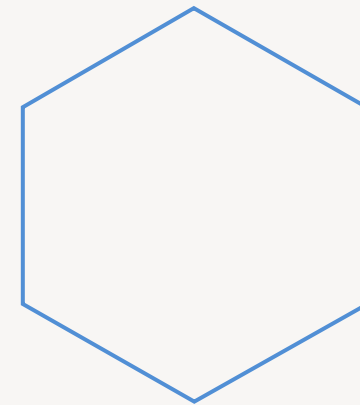


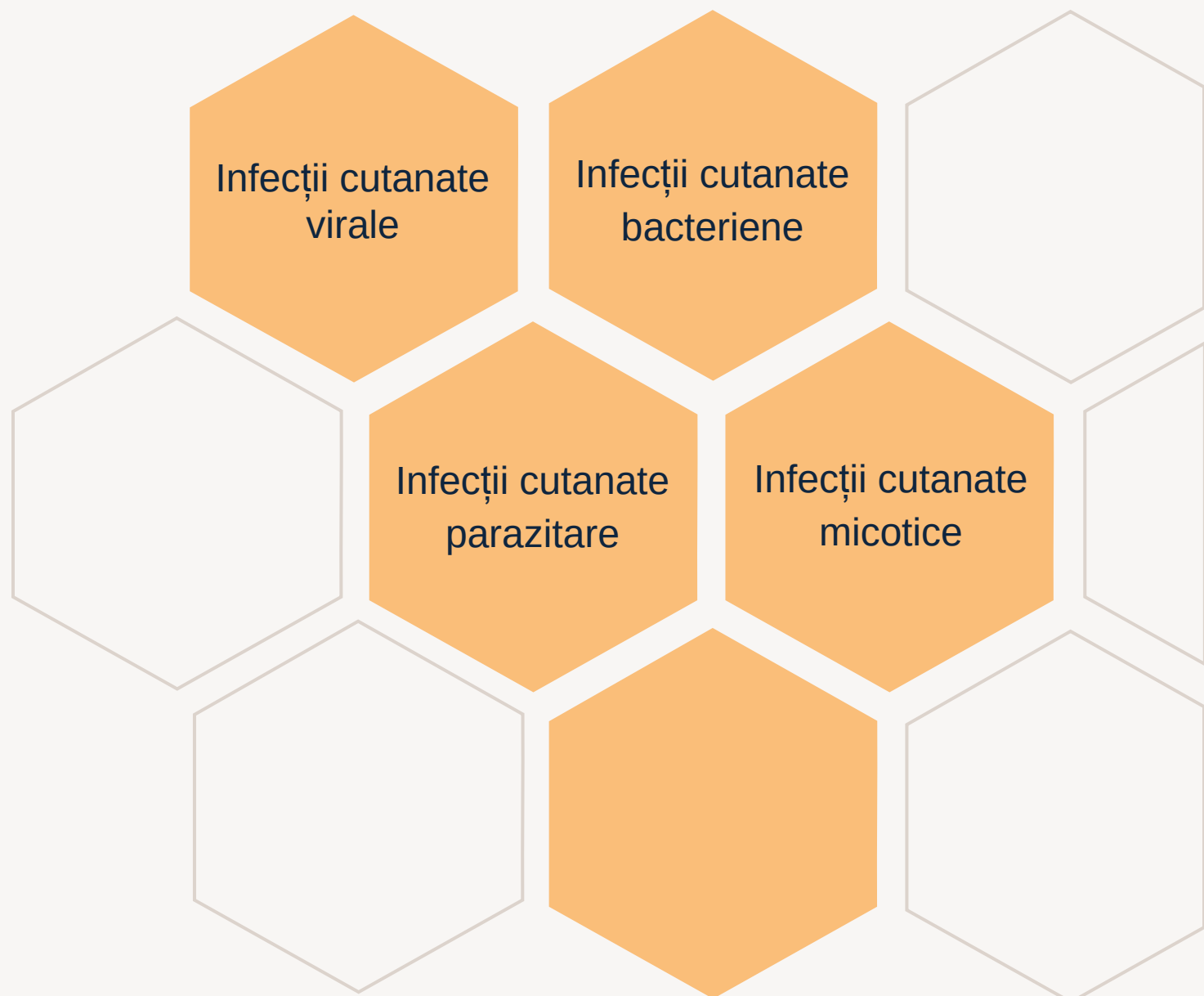
Infectii cutanate

Lector Dr Elisabeta Candrea





Infecții cutanate



Herpes simplex

- HSV 1
- HSV 2

Herpes simplex tip 1: infecție orofacială

Herpes simplex tip 2: infecție genitală și perigenitală

Oral: HSV-1 (80-90%),

Urogenital: HSV-2 (70-90%)

Primoinfecția cu herpes simplex: manifestări clinice pronunțate

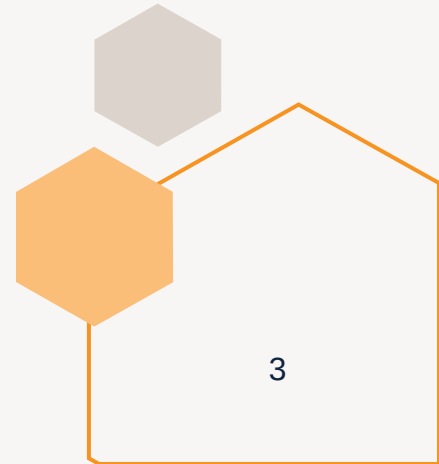
Ulterior: perioade de **reactivare** a virusului

Indivizii infectați : asimptomatici sau cu reactivare subclinică (pot transmite virusul)



Transmiterea: contact cu un fluid ce conține particule virale (salivă), contact direct cu o leziune activă sau picături respiratorii

- Infecție primară → Infecție latentă → Reactivare



Primoinfectia cu Herpes simplex

- Durere, senzație de arsură, parestezii

Vezicule grupate pe un fond eritematos

- Eroziuni în cavitatea bucală/ zonă genitală
- Vindecare după 1-4 săptămâni fără cicatrici
- Primoinfectia apare frecvent la copii, eroziuni/ulcerații orale, limfadenopatie, refuzul alimentației

Forme clinice:

- Gingivo-stomatită herpetică
- Keratito-conjunctivită herpetică
- Herpes cutanat primar
- Herpes genital
- Forme severe de herpes

Apare la 3-7
zile după
contact



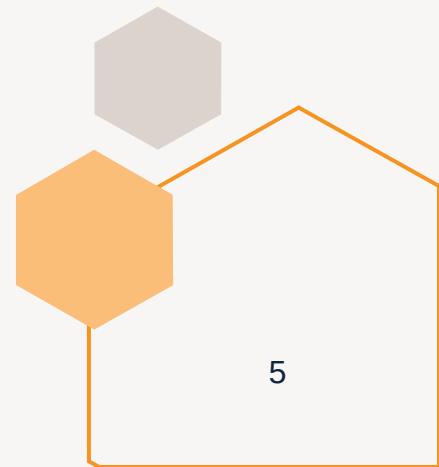
Reactivarea Herpes simplex

Factori precipitanți:

- expunere UV,
- Febra,
- Menstruatia,
- Iritație locală/ mecanică,
- stresul fizic/psihoemotional,
- manopere estetice (fața)
- Factori care modifică răspunsul imun: neoplazii, medicamente imunosupresoare, radioterapie, glucocorticoizi sistemici, etc

Prodrom: durere locala, arsura, prurit

Vezicule grupate pe un fond eritematos (24/48 ore), +/- adenopatie locala dureroasa, Reaparitia în același loc





Herpes simplex







(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131 - 85 - 2727

Complicatii:

- Eczema herpeticum
(primo-infecție/recurentă, pacienți atopici, erupție diseminată, febră, stare generală alterată)



Tratament

Tratament local:

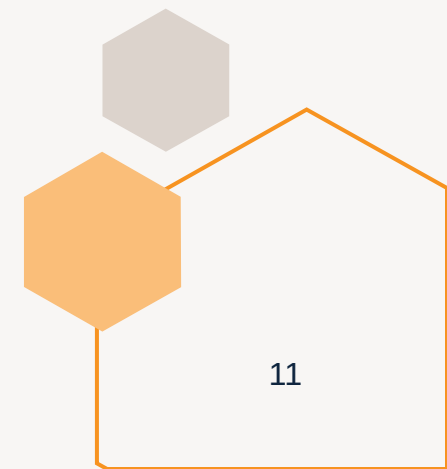
Aciclovir crema 4-5 aplicatii/zi pana la vindecare,
antiseptice locale

Tratament sistemic:

Aciclovir 1g/zi (200mgx5) 1 saptamana in timpul eruptiei

Valaciclovir: 1g/zi 5 zile

Profilaxia recurentelor (> 6 pe an): 400-800 mg Aciclovir / zi timp de 6 luni



Zona zoster

Zona zoster

Virus varicelo- zosterian

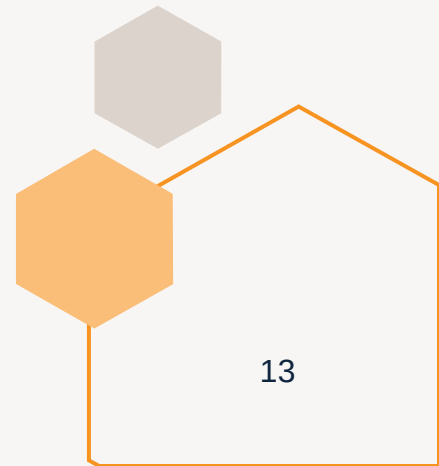
Infecția primară:

varicela → virus latent în ganglionii senzitivi

Reactivare virală → **herpes zoster**

Reactivare virală: factor trigger (interventii chirurgicale, imunosupresie (TBC, HIV/SIDA, neoplazii), vârstă înaintată

Incidența crește cu vârsta



Zona zoster- aspecte clinice

Prodrom: arsura locala, hiperestezie, durere la nivelul dermatomului afectat

Eruptie unilaterala, in banda, dermatomica

Placi eritematoase, alcatuite din vezicule grupate in buchet, lichid clar/ tulbure, eroziuni si cruste

Evolutie: 10-14 zile

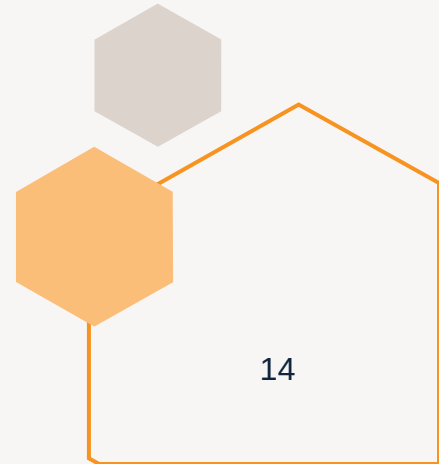
Vindecare cu macule hipo/hiper-pigmentate

Localizari: intercostal, lombosacrat, cervical, etc

Mucoase: pot aparea vezicule, eroziuni in cavitatea bucala, zona genitala

Ochi: afectare a ramurii oftalmice a nervului trigeminal

Cavitate bucala: ramurile 2, 3 ale nervului trigeminal
palat dur, maxila, limba, mandibula





(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131 - 85 - 2727

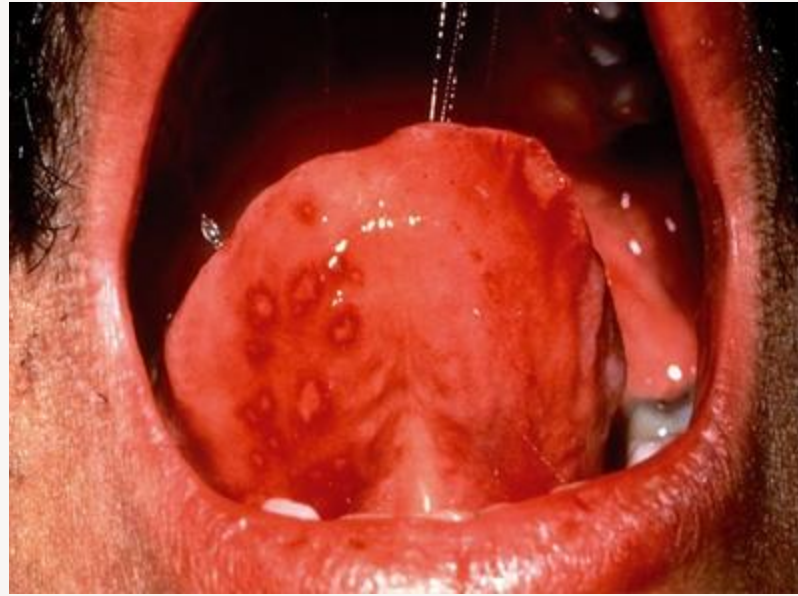


Herpes zoster

Herpes Zoster







Tratament

Prevenție: Imunizare prin vaccin (Zostavax, Shingrix)

Local: antiseptice, desicante topice

Sistemic: tratament antiviral, se inițiază în primele 24-48 ore

Aciclovir 800mgx 5/zi 7-10 zile

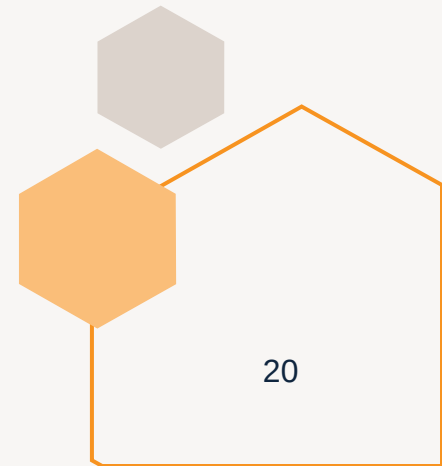
Valaciclovir 1gx 3/zi 7 zile

Brivudina (Brival) 125mg, 1 tableta/zi

Terapia durerii:

Gabapentin 300-900 mg/zi

analgice topice și sistemice



Virusurile papiloma umane (HPV)

Peste 150 de subtipuri virale de HPV

Incidenta crescuta (decada 2)

Infectivitate mare

Transmitere contact direct sau indirect

Anumite tulpini au risc oncogenic înalt (6,
11, 16, 18, 31, 33)

Majoritatea: risc oncogenic scazut



Veruci vulgare

- Papule mici, bine delimitate
- Culoarea pielii, unice/multiple-confluate
- Suprafața netedă→hiperkeratozic
- Copii/tineri
- Extindere în apropiere a leziunilor
- Localizari multiple (mâini, fata, scalp, tălpi)





DOIA

(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131- 85 - 2727



(c) University Erlangen.
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131- 85 - 2727



[c] University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131 - 85 - 2727



(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131-85-2727



Veruci ano-genitale/condiloame acuminat

Zona genitală sau perianal atât la femei cât și la bărbați

Transmitere prin contact sexual

Papule cu aspect conopidiform, (agregate, elevate)/plane



(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131 - 85 - 2727

Tratament veruci

- Keratolitice (Duofilm): acid salicilic+acid lactic
- Crioterapie
- Zona genitală:
 - Podofilina/podofilotoxina (Condyline solutie)
 - Aldara (Imiquimod 5 %)
 - Extract de ceai verde (Veregen)
- Alte posibilități terapeutice:
 - Diatermocausterizare
 - Laserterapie (CO2, vascular)
- Prevenție: vaccinare anti-HPV : Cervarix (16,18), Gardasil (6,11,16,18), Gardasil 9 (împotriva a 9 tulpini HPV)

Multumesc

